Etablissement hospitalier universitaire 1er novembre d'Oran
Faculté de médecine d'Oran
DR .ZERRIAHEN maitre assistant en chirurgie vasculaire



Sémiologie veineuse

zer.abdel.med@gmail.com

Le 20/10/2025

Rappel anatomique :

Les veines du membre inférieur constituent 2 réseaux:

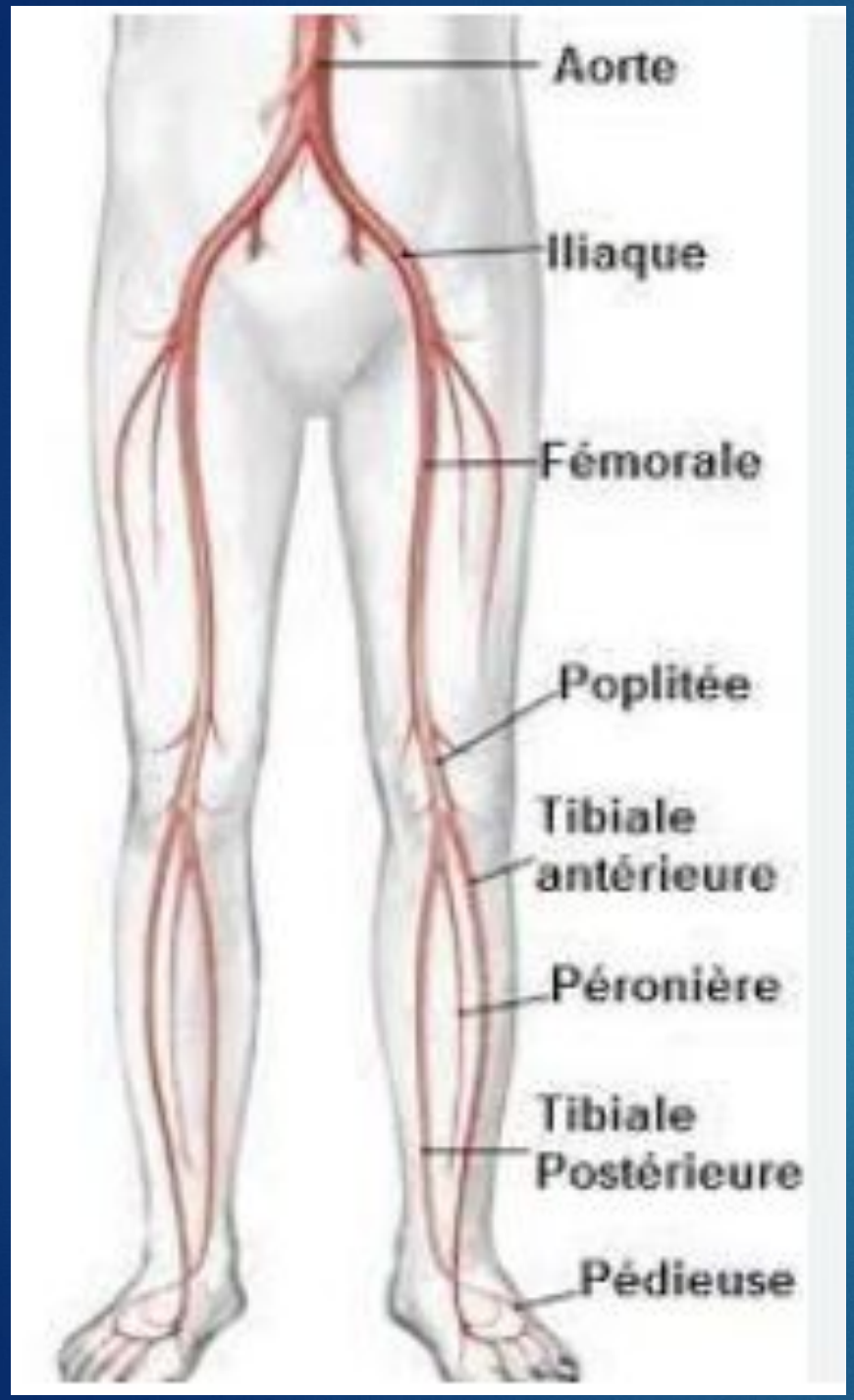
réseau veineux profond

Le réseau veineux profond suit le trajet des artères depuis le pied jusqu'à l'aine.

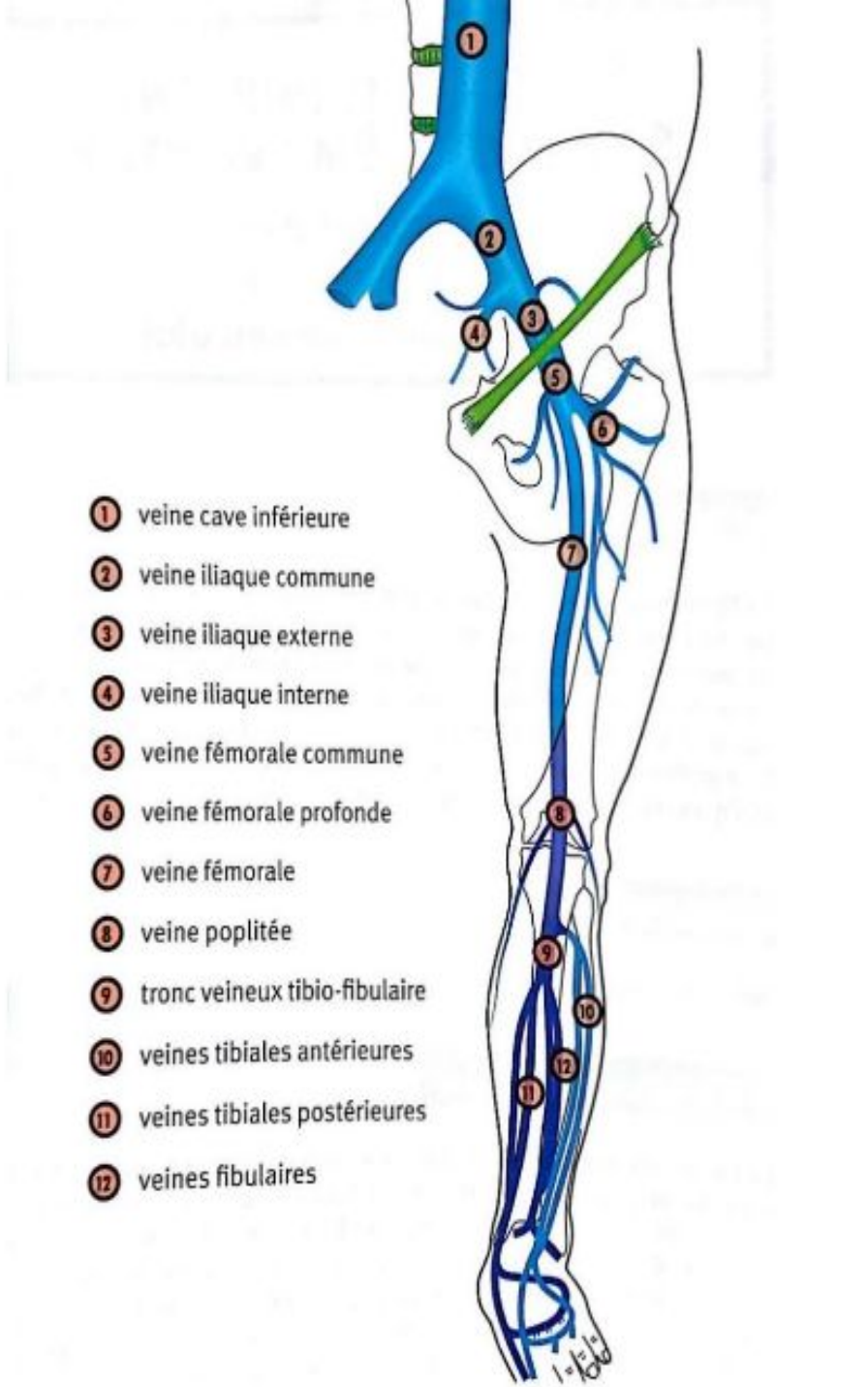
Les veines de ce réseau portent le même nom que les artères qui l'accompagnent et sont dédoublées de la cheville au genou puis unique de la poplitée au confluent ilio-cave. Ce réseau aboutit à la veine cave qui remonte vers le cœur. Il draine 90% du sang

réseau veineux superficiel

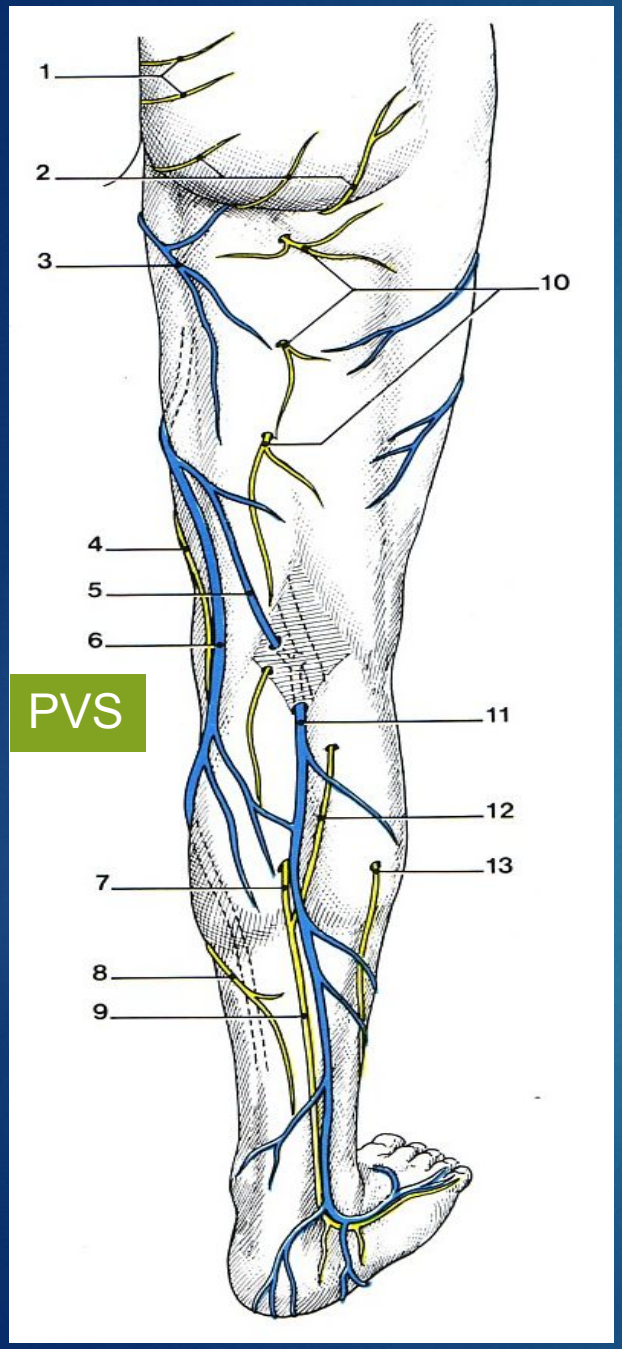
Les veines superficielles cheminent entre le derme et le fascia musculaire; ce réseau est donc sus-aponévrotique. Il draine que 10% du sang veineux.
Le RVS des membres inférieurs est essentiellement composé par les veines Saphènes qui prennent leur origine au niveau du pied.
C'est ce réseau qui sera le siège des varices



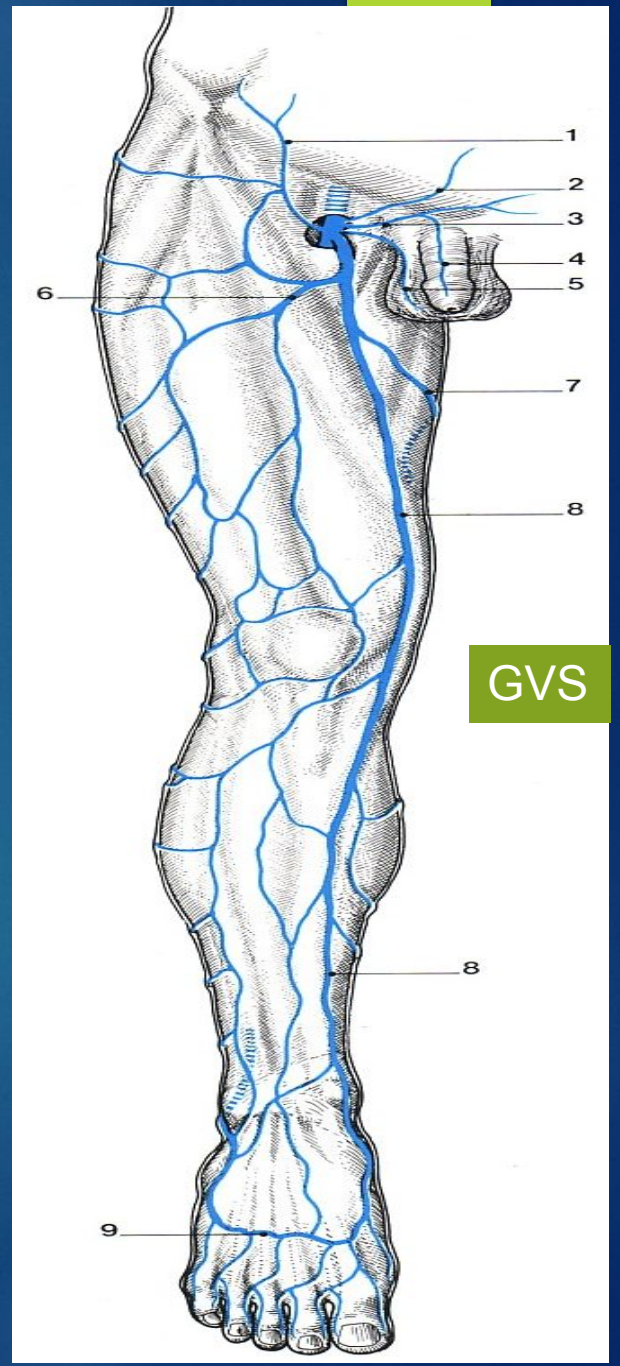
Réseau veineux profond



Réseau veineux superficiel

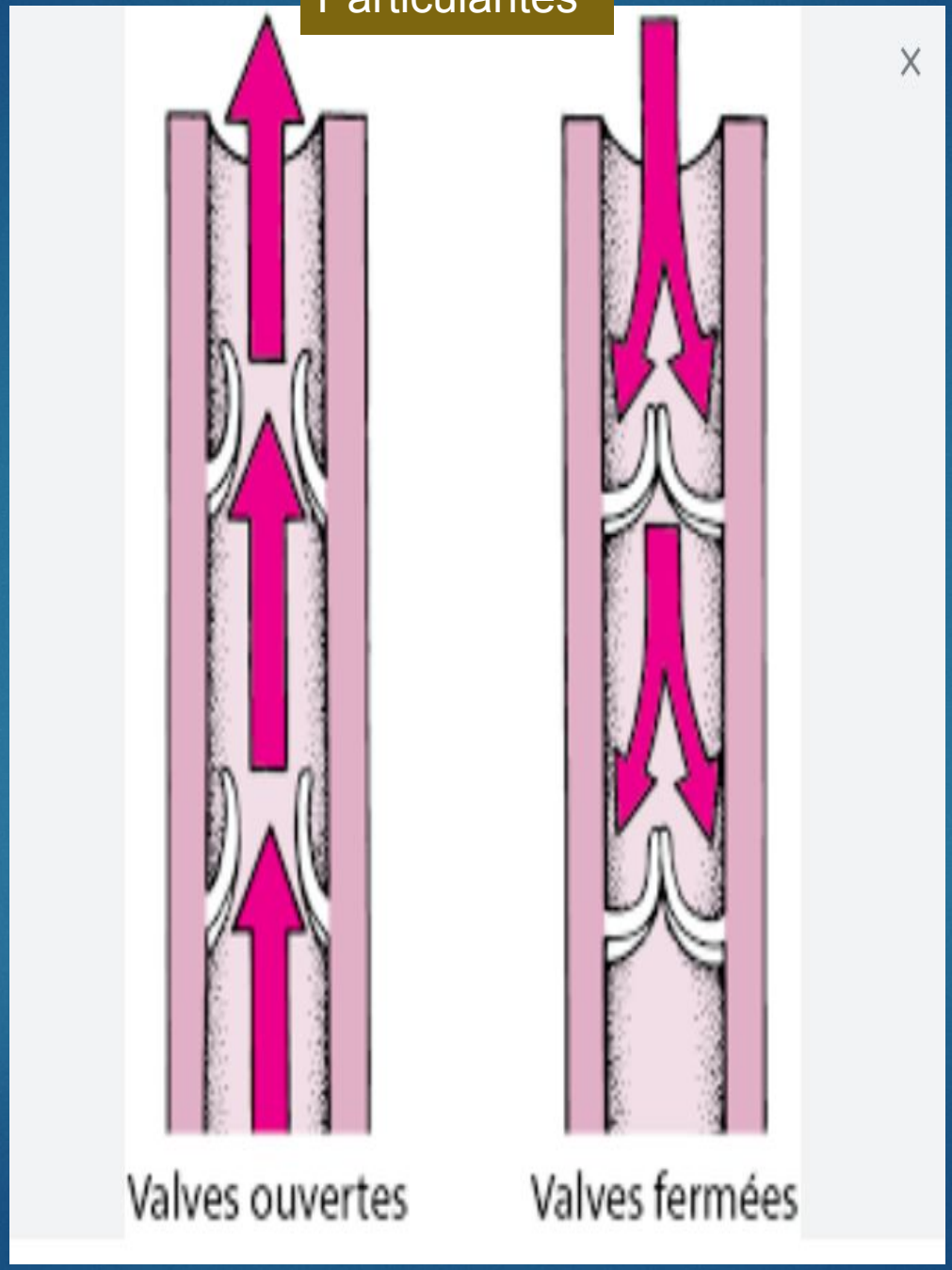


PVS



GVS

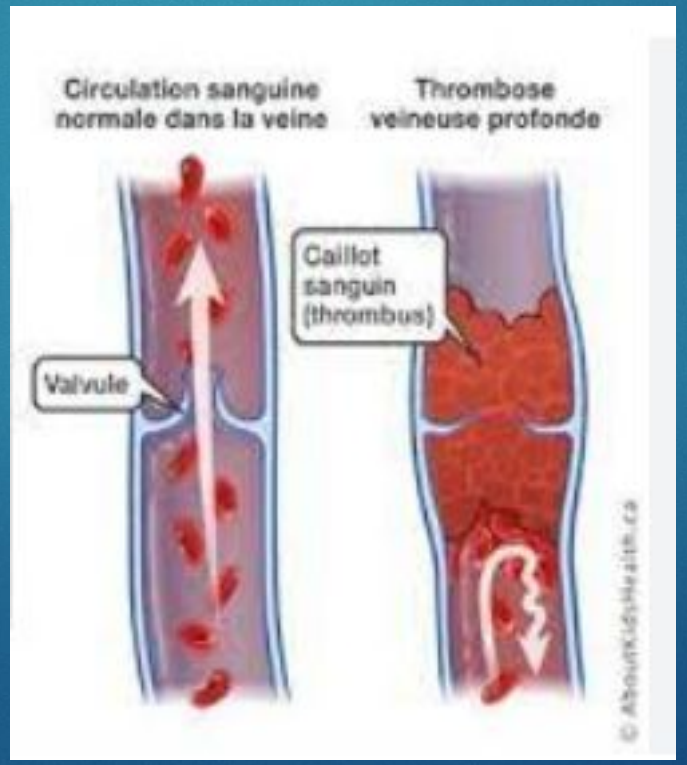
Particularités



I. Pathologie du système veineux profond

Thrombose veineuse profonde(TVP)+++

Elle se définis par une oblitération plus au moins étendue d'une veine profonde par la constitution et le développement dans sa lumière d'un thrombus .





Risque immédiat

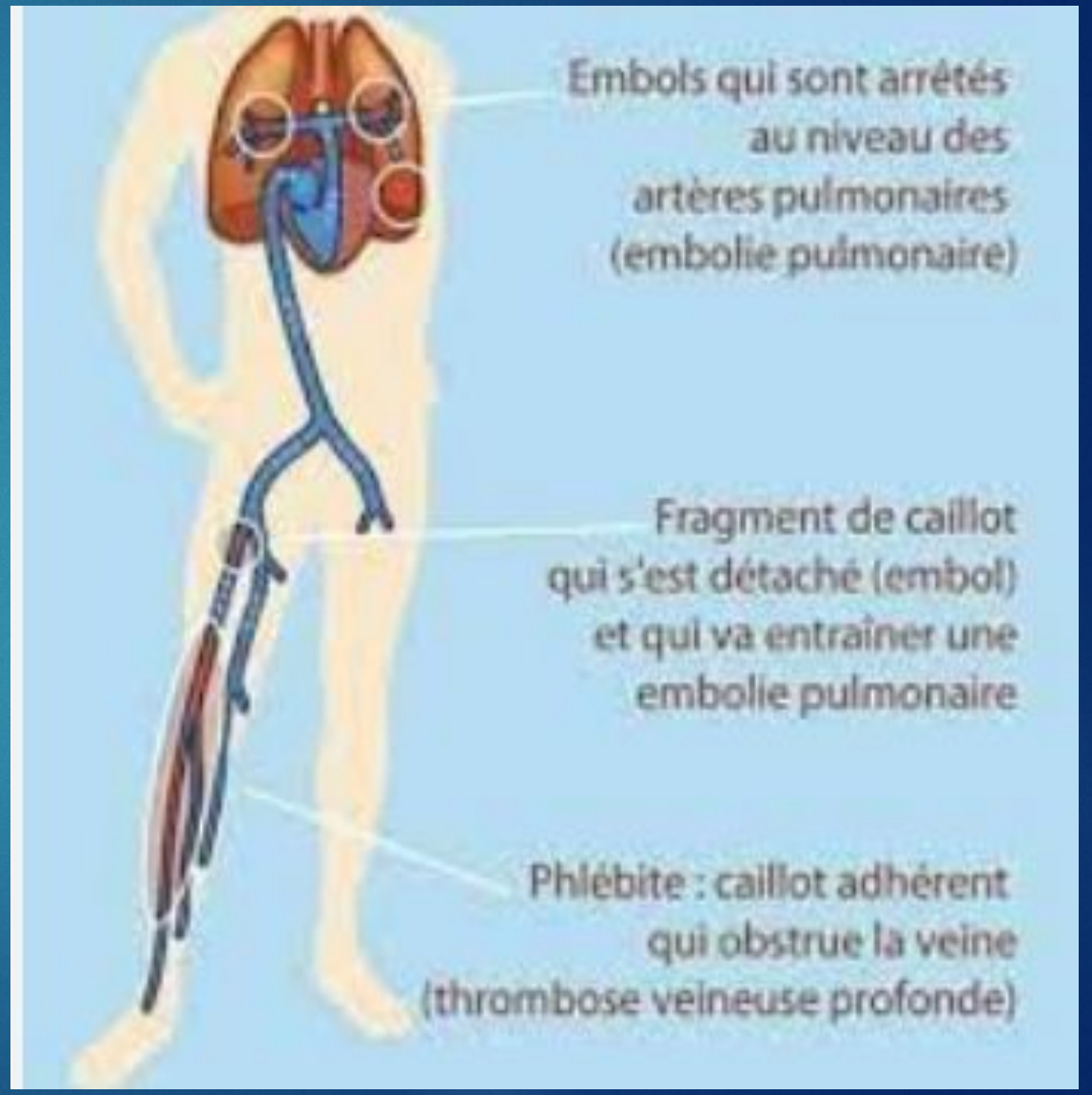
Embolie pulmonaire

Risque à long terme

maladie post phlébitique

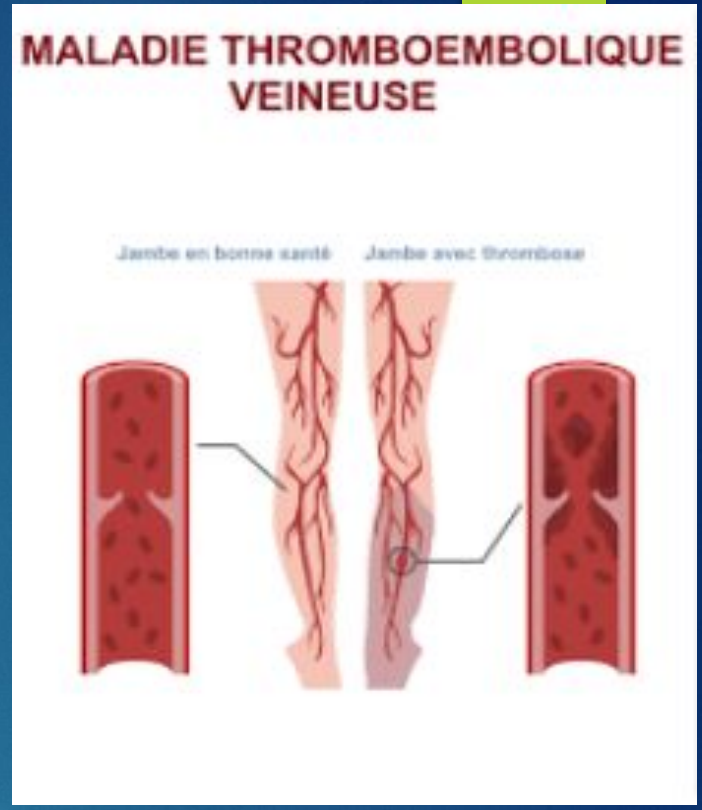
- Embolie pulmonaire :

Lors de son trajet de retour de la périphérie vers le cœur, le sang veineux passe par les poumons. A ce niveau, les caillots qui remontent avec la circulation peuvent se bloquer dans les vaisseaux pulmonaires. Suivant la taille du caillot, la conséquence peut aller jusqu'à un éventuel arrêt cardiaque. Il faut donc s'assurer d'avoir tout mis en œuvre pour porter un jugement juste.



- Maladie post phlébitique :

Il s’explique par l’anatomie des veines profondes. En effet, elles possèdent un système de valvules qui aident la remontée du flux sanguin.
Après la mise en place d'un caillot, dans un premier temps le sang ne passe plus (or ce n'est pas vraiment le problème car il existe d'importantes circulations collatérales qui prennent le relais) puis rapidement une réaction inflammatoire se met en place et permet la thrombolyse. Cependant, cette disparition du caillot est accompagnée d'une destruction des valvules qui provoque un reflux et une stase veineuse.
Cette dévalvulation entraîne des problèmes fonctionnels handicapants à long terme (plusieurs années)





Physiopathologie de la TVP

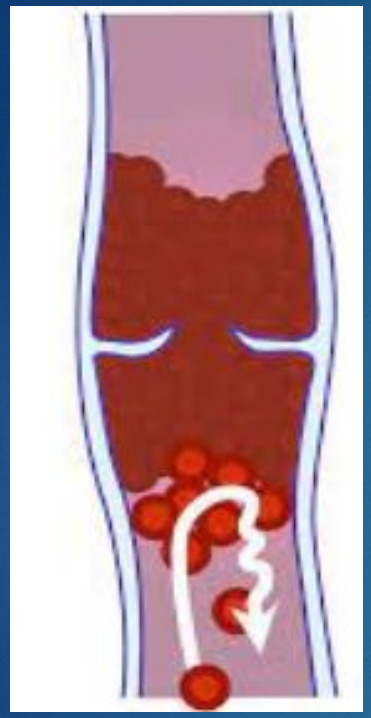
Stase veineuse

Altération pariétale

Triade de WIRSCHOW

État d'hypercoagulabilité

- L’évolution du thrombus:



Dissolution

L’organisation et inflammation

La fragmentation

Diagnostique clinique de TVP

- Les signes fictionnels et cliniques de la TVP sont peu sensible et peu spécifique .

- Il faut chercher les situations à risques (interrogatoire minutieux) .



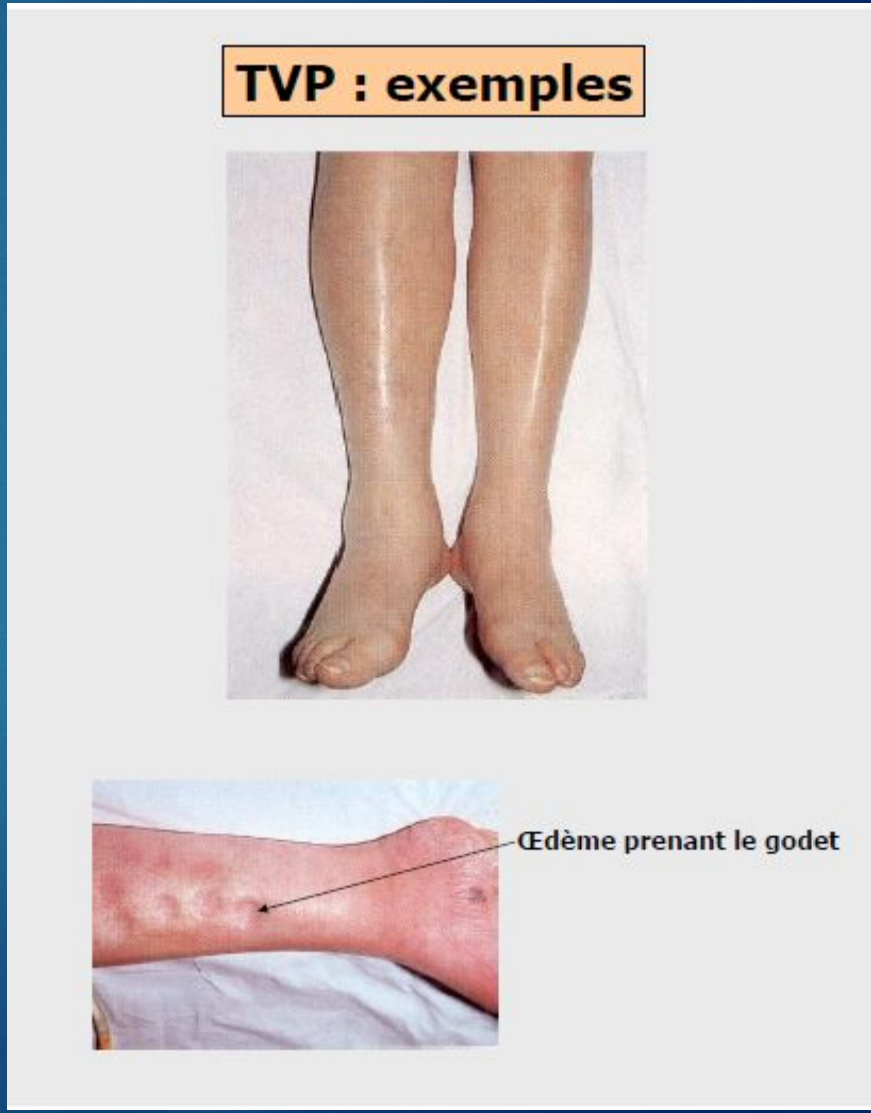
Les signes cloniques de la TVP sont souvent **unilatéraux++++**

La douleur: spontanée ou provoquée à la palpation ,

retrouvée chez seulement 60% des patients .

Œdème : unilatéral et prend le godet .

Si la thrombose est surale, on va avoir un œdème au niveau du mollet et de la cheville tandis que lorsque la thrombose est iliaque, il s'étendra sur tout le membre. De même, ce signe est inconstant (retrouvé chez 60% des patients).



Fébricule /chaleur cutanée locale



Dilatation veineuse superficielle





l'examen clinique :

- Une diminution du ballottement du mollet:

- Le signe de Homans : douleur au mollet à la dorsiflexion du pied due à la compression des veines profondes par les muscles .



Une augmentation du diamètre du mollet, en comparaison avec le mollet controlatéral

La palpation des pouls



L'examen clinique doit être bilatérale et comparatif+++

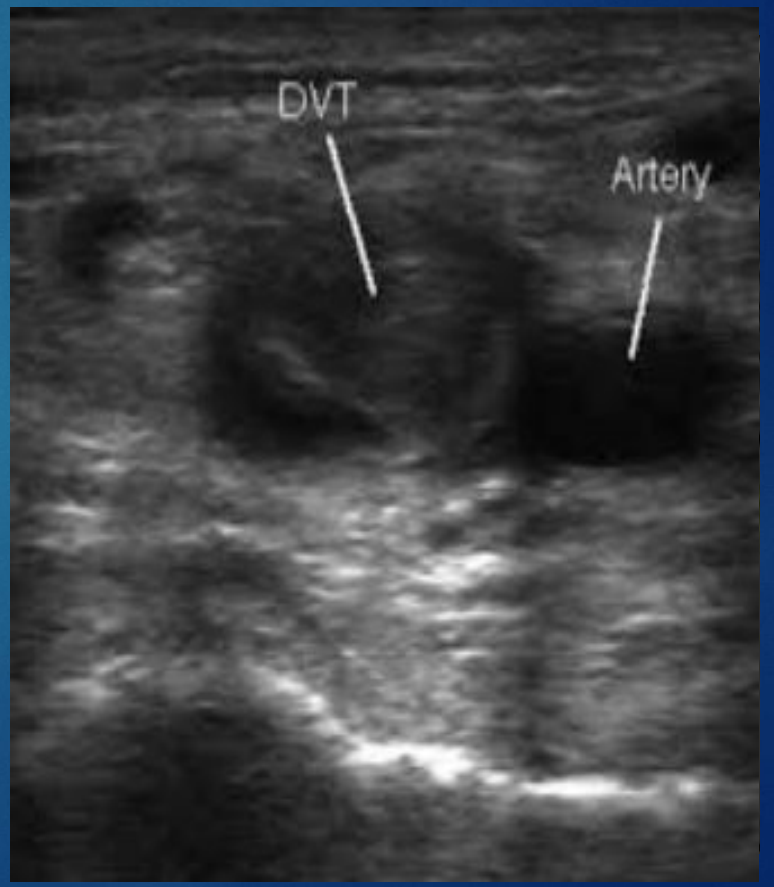
Examen complémentaire :

Test biologique des D-dimères sanguins : valeur prédictive négative.

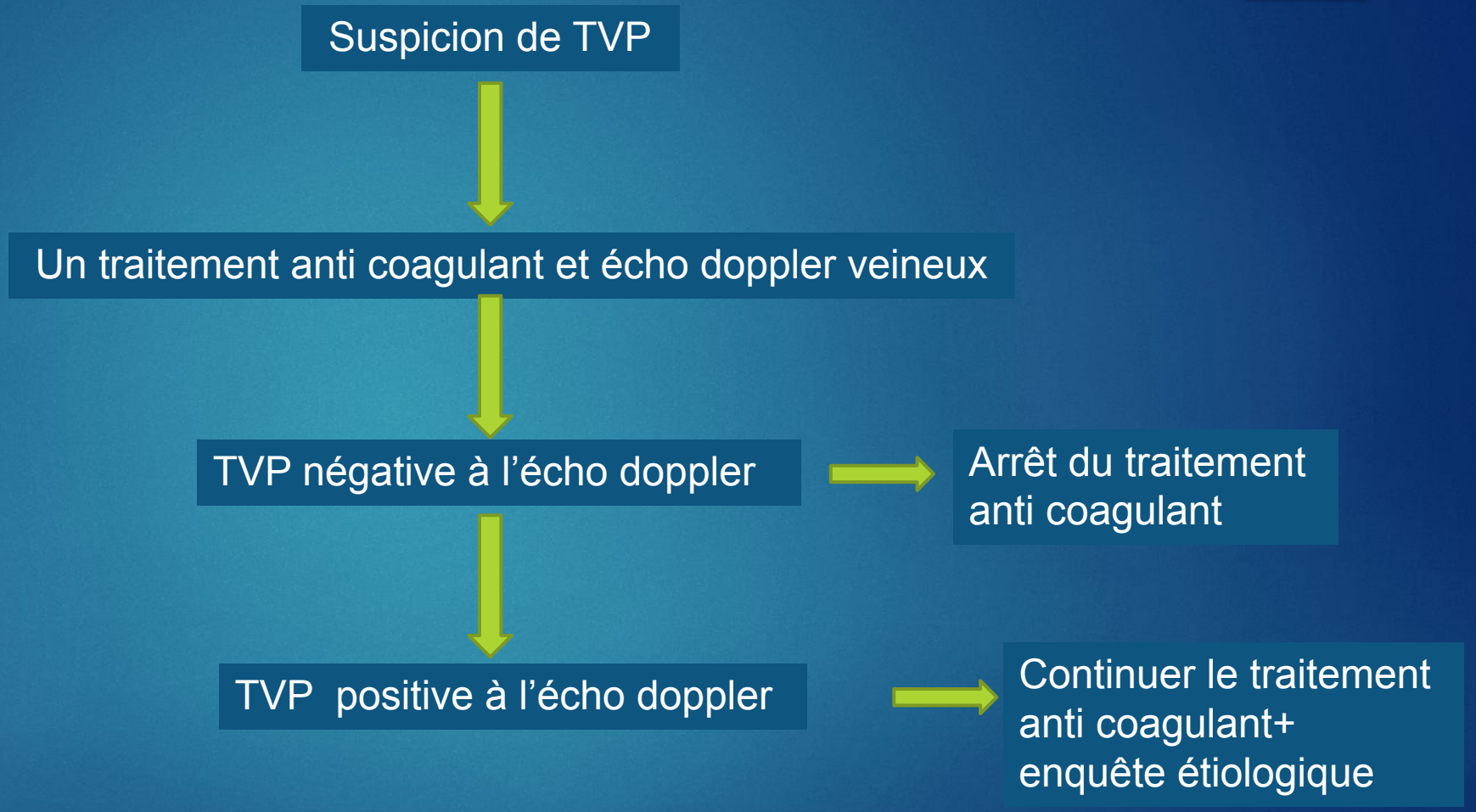
D-dimères négatif : élimine le diagnostique

D-dimères postif : elle ne pose pas le diagnostique

Echodoppler veineux : c'est l'examen principal du diagnostic



A retenir +++++


Suspicion de TVP
Un traitement anti coagulant et écho doppler veineux
TVP négative à l'écho doppler
Arrêt du traitement anti coagulant
TVP positive à l'écho doppler
Continuer le traitement anti coagulant+ enquête étiologique

Situations à risque +++

Chirurgie orthopédique +++

Alitement prolongé

Position assise prolongée

Chirurgie générale

Cancer +++

Thrombophilie : histoire familiale de TVP/EP

Forme clinique

- **Phlegmatia alba dolens (phlébite bleue) :**

Forme clinique rare

Associée à des signes d'ischémies .

Peut simuler une ischémie aigue





Pièges diagnostique

Erysipèle

l'hématome du mollet

déchirure musculaire

thrombose veineuse superficielle

kyste synovial poplité

lympoedème

Douleur neurologique

À retenir

Une TVP c’est une véritable urgence diagnostique et thérapeutique



II. Pathologie du système veineux superficiel

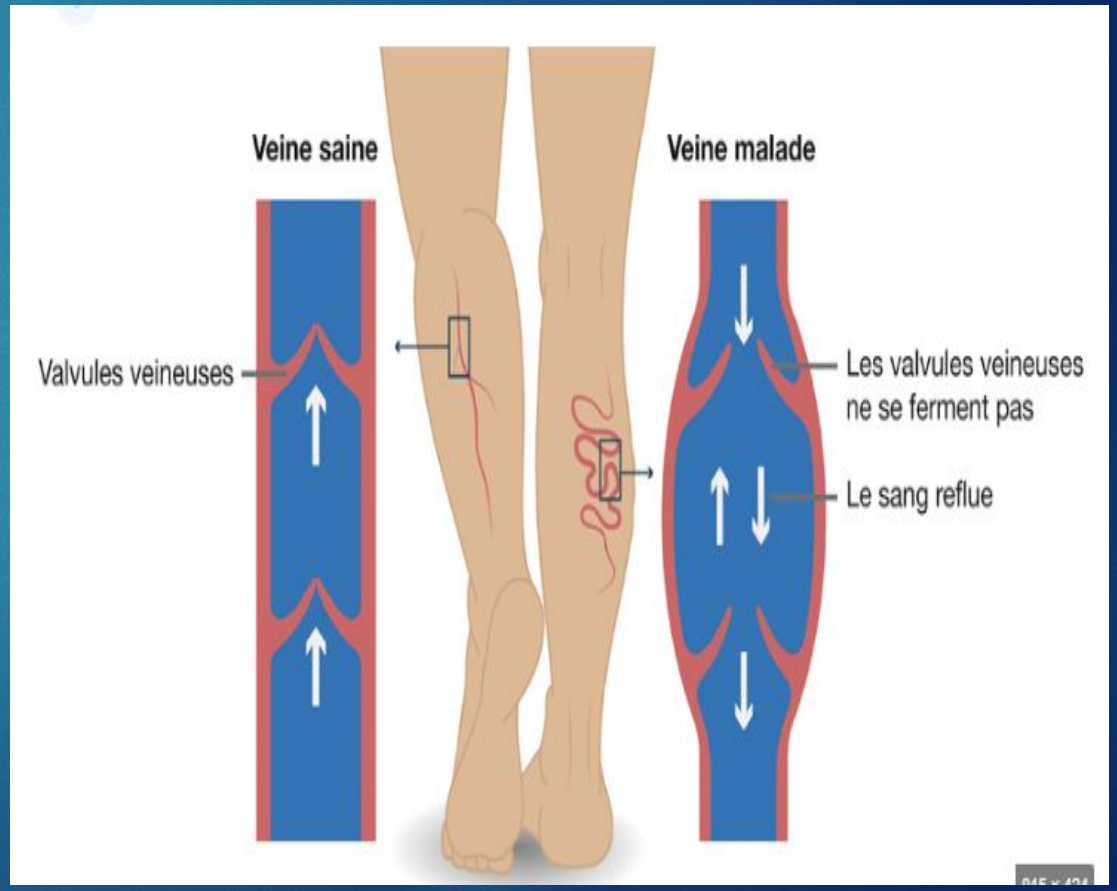
Varice des membres inferieurs

- Maladie fréquente 30 à 40 % de la population.
- Affection relativement bénigne.
- But du traitement :
  - Supprimer les symptômes.
  - Eviter ou prévenir les complications
  - Esthétique

Définition :

- Varices des membres inférieurs se définissent comme un reflux de sang dans les veines superficielles entraînant une dilatation permanente et une élongation des veines superficielles dont le trajet devient tortueux, et qui peut s' accompagner d'une altération de la peau (ulcère, dermite ocre etc.…) en absence d'un traitement efficace.

- Dans la majorité des cas ,aucune cause ,varices essentielles

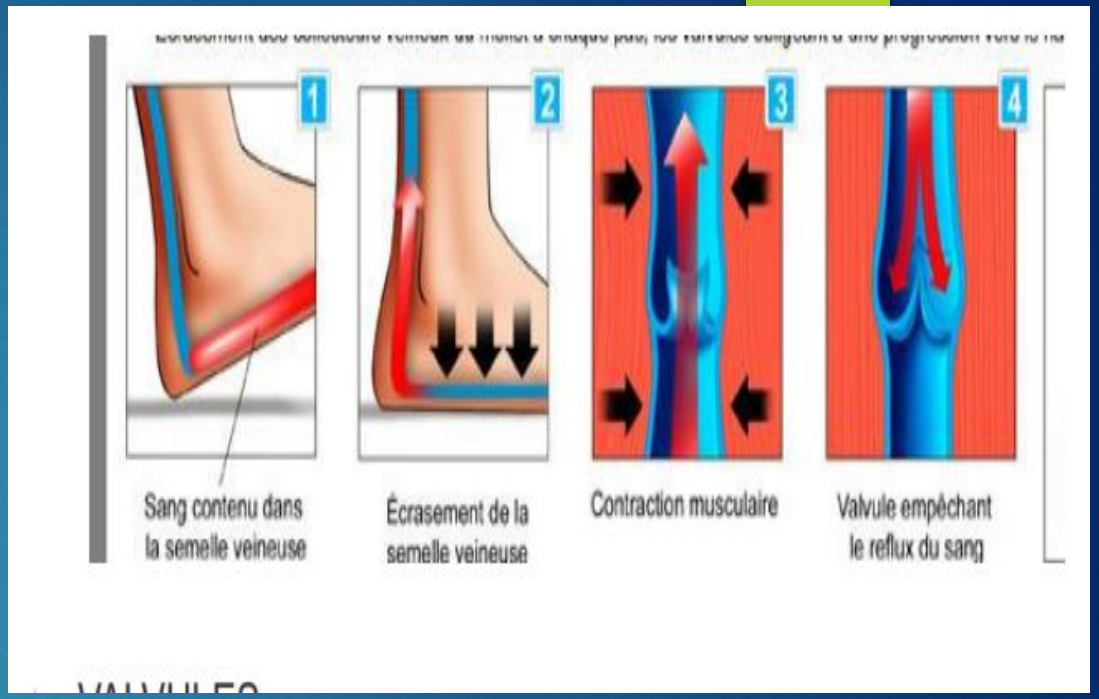


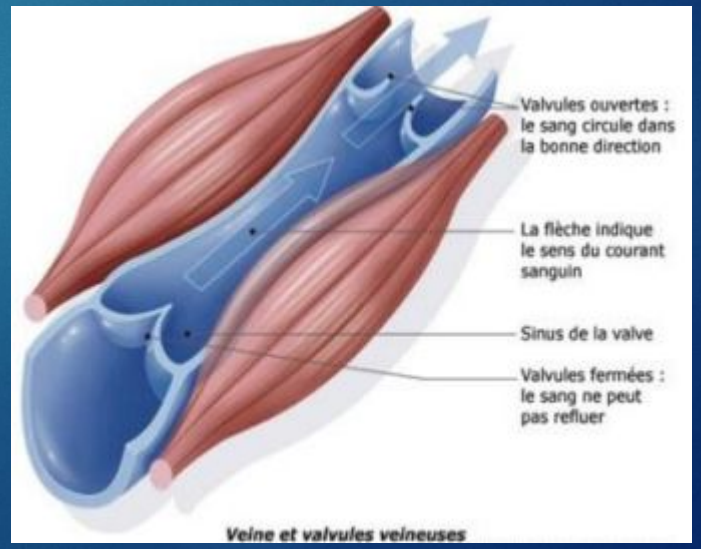
Physiologie du retour veineux :

- **Comment le sang veineux remonte t-il ?**

les mécanismes permettant le retour veineux

- aspiration cardiaque (diastole).
- respiration abdominale et le rôle du diaphragme.
- le tonus et contractilités des veines.
- écrasement de la semelle veineuse et la voûte plantaire.
- la pompe musculaire du mollet.





NOTIONS ETIOLOGIQUES

- Varices essentielles.
- Varices secondaires n’apparaissent qu’au cours de la vie.

LES FACTEURS PREDISPOSANT:

Les facteurs déclenchant : sont nombreux.

- troubles endocriniens chez la femme (puberté, grossesse, ménopause, contraception orale,etc..)
- obésité.
- compression : fibrome utérin.
- position debout prolongée obligatoire pour certaines professions.
- sédentarité exagérée.
- la chaleur (soleil, sauna).
- pied plat.
- les talons trop haut.
- les gaines et collants trop étroits.

MOTIF DE CONSULTATION :

- Problème esthétique (++++) : il s’agit de varicosités ou de paquets variqueux tortueuse, inesthétique.

- Lourdeur de jambe, majorée par orthostatisme.

- Complications médicales :
  - prurit ou démangeaisons.
  - dermite ocre.
  - phlébite superficielle (douleur et rougeur).
  - ulcère variqueux.



SYMPTOMATOLOGIE:

- La maladie variqueuse évolue en 4 stades

stade I : pas de varice visible, mais présence de signes fonctionnels : lourdeur des jambes, crampes nocturnes, paresthésies (fourmillement), douleur le long du trajet veineux, prurit, œdème de la cheville le soir.

stade II : varices visibles.

stade III : troubles trophiques : dermite ocre.

stade IV : ulcère variqueux, plaie provoquée par un traumatisme aucune tendance naturelle à la cicatrisation.

EXAMEN CLINIQUE

INSPECTION:

- Malade en position debout et couché.
  - dilatation variqueuse tortueuse, inesthétique.
  - trajet par rapport aux 2 saphènes.
  - lésions cutanées (dermite ocre ou ulcère).
  - phlébite superficielle.



PALPATION:

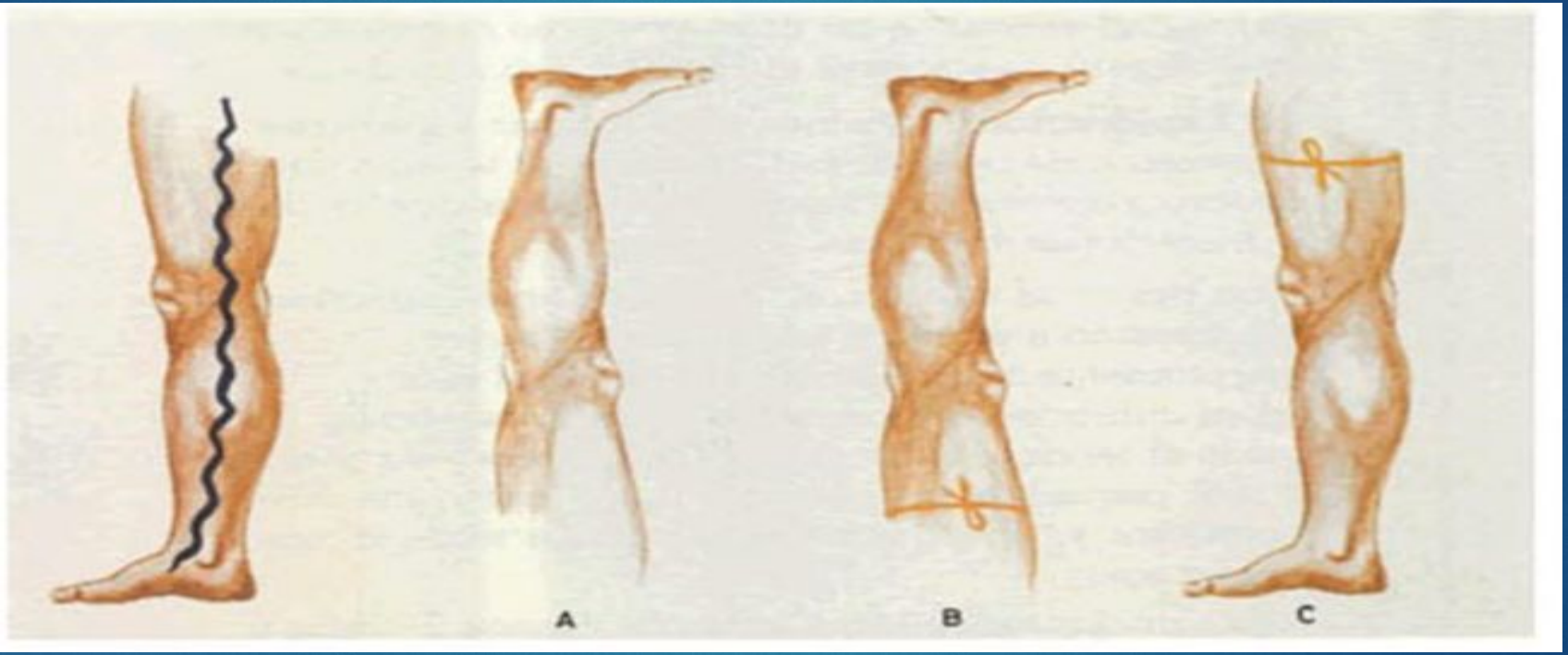
- Palper de proche en proche du trajet des veines saphènes (GVS et PVS).
- Palpation des pouls .
- **Manœuvre de Schwartz :** la percussion rapide au niveau du trajet de la GVS, et la palpation veineuse simultanée d'amont pour percevoir l'arrive d'une onde liquidienne déclenchée par cette percussion







Manœuvre de Trendelenburg : pose d'un garrot au-dessus des paquets variqueux la jambe surélevée, et remplissage des varices lors du passage en position déclive)



Manœuvre de Trendelenburg





- **<u>Manœuvre de PERTHES</u> :** garrot à mi-cuisse, puis faire marcher le malade pendant 5 mn.

  veine se vide → normal.

  veines restent dilatées → incontinence



AUSCULTATION

Auscultation des paquets variqueux à la recherche d’un souffle.

AUTRE EXAMEN :

- cœur.
- artère.
- abdomen.
- poumon.

EXPLORATION

- BUT :

  - perméabilité et continence du réseau profond.

  - mécanisme de l’insuffisance veineuse superficielle.

  - topographie et quantification des reflux.

- **Echographie doppler : +++ (1ere intention)**

  Renseigne sur la perméabilité de la veine, l'existence de reflux (certaines manœuvres dynamiques permettent la recherche du reflux).

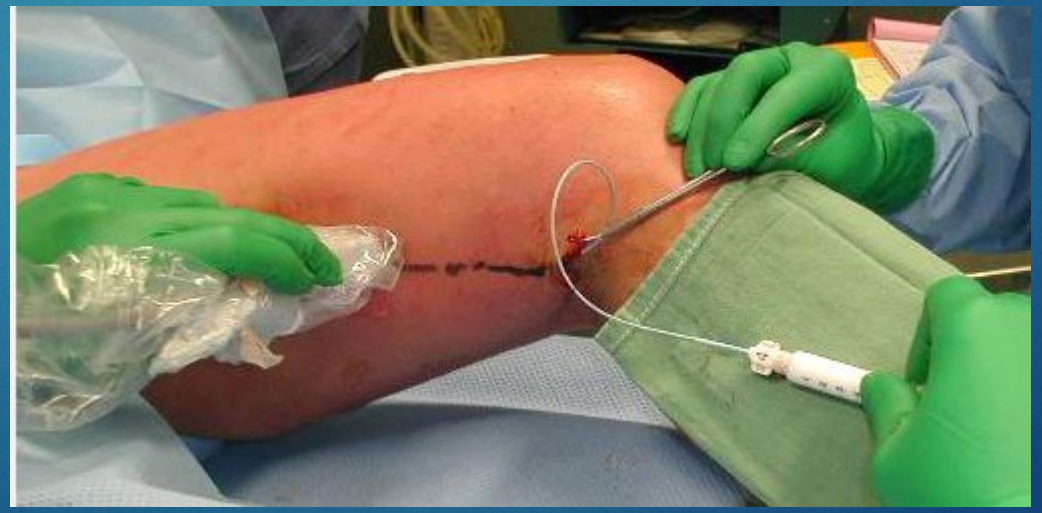




traitement:

- la contention élastique
- La chirurgie (classique et mini invasive)







MERCI